Sífilis nasal y paranasal

A Ennouri
H Hajri
N Bouzouaa

Resumen. – *La sífilis es una enfermedad general causada por el* Treponema pallidum, *bacteria gramnegativa en espiral. Su gran contagiosidad, su larga evolución y la lesión de todos los tejidos del organismo dan a la enfermedad sus características específicas* [1].
En ausencia de antibioticoterapia específica, la sífilis evoluciona en tres estadios, de manera crónica, hacia lesiones viscerales destructivas. En todos los estadios de su evolución puede haber manifestaciones nasales y paranasales, que provocan secuestros osteocartilaginosos y pérdidas de sustancia importantes. Actualmente, desde que la sífilis se diagnostica y se trata más precozmente, estas lesiones son excepcionales. Existen focos de sífilis endémica, no venérea, en América Latina y en África central, conocidos con distintos nombres: pian, bejel, carate [7].

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Generalidades

La sífilis es una infección debida al *Treponema pallidum*, bacteria helicoidal de 6 a 12 µ de largo, de la clase espiroqueta. A diferencia de la mayoría de las bacterias móviles, su movilidad se lleva a cabo por un filamento axial interno. Se puede ver en el microscopio de campo oscuro.

En la mayoría de los casos, la contaminación es por vía sexual. La sífilis también se puede transmitir in utero por una madre contaminada, por instrumentos, objetos contaminados y/o por sangre (transfusión) cuando los donantes están en fase preserológica.

El período de incubación varía de 10 a 90 días, con una media de 3 semanas.

La historia natural de la enfermedad puede dividirse en varios períodos: primario, secundario, latente y terciario.

En los países en vías de desarrollo la sífilis sigue siendo una enfermedad endémica. Según Géniaux [3], en África, en los centros de protección materna e infantil (PMI), el 10 % de las madres presentan sífilis evolutiva.

En los países industrializados, a partir de 1985, su frecuencia está en clara regresión y se relaciona con los medios de protección por miedo al SIDA, sobre todo en la población homosexual.

A Ennouri : Professeur universitaire, praticien hospitalier ORL.
H Hajri : Assistant des Hôpitaux et des Universités.
N Bouzouaa : Assistant des Hôpitaux et des Universités.
Hôpital Charles-Nicolle, Tunis, Tunisie.

Clínica

SÍFILIS PRIMARIA

Se caracteriza por la asociación de un chancro de inoculación y una adenopatía satélite. Dura entre 6 y 8 semanas.

El chancro de inoculación en la nariz es muy poco frecuente. Aparece en la parte anterior del tabique nasal, sobre todo, en el hombre adulto. Esta localización, según los antiguos sifilógrafos, confirma la etiología digitoungueal, aunque también se han visto contaminaciones por medio de un pañuelo, de un cuerpo extraño en la narina y por la tabaquera anatómica en las personas que aspiran tabaco.

Los signos funcionales son una rinorrea serosa, acompañada de una obstrucción nasal unilateral [8, 9].

Por medio de una rinoscopia anterior se ve el chancro de inoculación: es una ulceración indolora, única, ovalada, de 4 a 6 mm de diámetro, bien circunscrita, de borde indurado, roja exudativa con fondo amarillento, que contiene varios treponemas visibles al microscopio de campo oscuro, «como si la mucosa hubiera sido cortada con una cucharilla», según la expresión de Jacod [6]. También puede haber chancros múltiples y dolorosos. El chancro, según su localización, se acompaña de una adenopatía parotídea o subdigástrica uni o bilateral. La cicatrización del chancro tarda 5 semanas, sin dejar cicatriz. La adenopatía persiste algunos meses y tiene un gran valor diagnóstico.

SÍFILIS SECUNDARIA

Aparece entre el segundo mes y el segundo año después de la contaminación. Este período corresponde a la generalización de la sífilis, con afectación cutaneomucosa y visceral. Son

lesiones abiertas con abundantes treponemas, que tienen un papel importante en la diseminación de la enfermedad.

El paciente, habitualmente febril, consulta por una rinitis mucosa unilateral persistente, acompañada de un exantema generalizado consistente en una erupción de manchas eritematosas, redondas, de color rosa pálido *(fig. 1).* Sobre el revestimiento cutáneo de la pirámide nasal pueden observarse todos los tipos de sifílides cutáneas descritas por Fournier [2]: sifílides papulosas, lenticulares o foliculares, de color cobrizo, asociadas a grietas exudativas del borde nasal. Estas lesiones evolucionan en brotes sucesivos durante algunas semanas y desaparecen dejando máculas pigmentadas que acaban borrándose.

En la rinoscopia se ve un eritema bermellón unilateral [4]. Se trata de una erupción formada por placas ovales, ligeramente sobreelevadas, de color rojo intenso, más abundantes en la parte anterior del tabique y en el cornete inferior. En el resto de la mucosa pituitaria aparecen ulceraciones superficiales, de bordes netos, que sangran al contacto y sobre una mucosa congestiva. Durante la sífilis secundaria suele haber una poliadenopatía cervical posterior. Se trata de ganglios pequeños, duros, móviles e indoloros. Es típica su ubicación occipital posterior, a lo largo de los bordes externos de los trapecios.

SÍFILIS TERCIARIA

Separada de la sífilis secundaria por un período de latencia largo o fase serológica, cuya duración puede ser de varios años, la sífilis terciaria se caracteriza por una evolución mutilante de las lesiones. Fournier [2] escribía: «La característica del período terciario consiste en afectar a todos los tejidos de una manera profunda, atacando su trama. La sífilis terciaria es parenquimatosa, ulcera, corroe, abre, destruye, desorganiza, atrofia...».

La sífilis terciaria agrupa lesiones localizadas, profundas y destructivas. El goma y el sifiloma son las consecuencias habituales y las más típicas. Estas dos formas no son específicas de las fosas nasales.

El goma es una tumefacción ovalada, de color rojo intenso, recubierta por una mucosa regular, indurada e indolora a la palpación. Generalmente es única, pero puede ser múltiple. Evoluciona en cuatro estadios sucesivos: induración, ablandamiento, ulceración y cicatrización, en un lapso variable de tres a seis meses.

Aunque puede localizarse en cualquier parte de las fosas nasales, la localización en la base, con una extensión hacia la bóveda palatina, representa el lugar de predilección, que conduce a la perforación del paladar óseo.

Los gomas comprimen y erosionan los órganos vecinos. Puede producirse una necrosis completa, con una ulceración amplia de la cara, que puede llegar a los labios y a las órbitas.

Es clásica la asociación de tuberculosis y sífilis cuando a las características de la infiltración gomosa se añaden las de la infiltración tuberculosa, con sus fístulas de bordes despegados y sus cicatrices desgarradas.

El sifiloma difuso, patognomónico de la sífilis nasal, consiste en pequeños tubérculos lenticulares que confluyen en una capa lisa o mamelonada, acompañados de elefantiasis.

El sifiloma afecta a todo el esqueleto nasal. La raíz nasal se inflama. La piel enrojece. La nariz está hinchada y dolorosa. Se forman secuestros que afectan a las pequeñas láminas óseas de los cornetes o vomerianas, que se expulsan espontáneamente, o bien se trata de secuestros voluminosos que permanecen en las fosas nasales durante varios meses, antes de fragmentarse y producir un olor nauseabundo característico *(fig. 2).*

Al terminar su evolución, las ulceraciones se cierran con una cicatriz retráctil, de bordes infiltrados, tallados verticalmente.

1 *Sífilis secundaria: sifílides cutaneomucosas.*

2 *Sífilis terciaria, deformación de la pirámide nasal. Reabsorción osteocartilaginosa. Sifiloma parotídeo derecho.*

Formas clínicas

SÍFILIS CONGÉNITA

Es una sífilis transmitida por la madre al feto, por vía transplacentaria, a partir de la novena semana de gestación. Es una sífilis activa, septicémica desde un principio, y sus manifestaciones serán tanto más graves cuanto más precoz y evolutiva sea la sífilis materna.

El signo más precoz y más importante del cuadro clínico es la coriza sifilítica. Aparece dos a ocho semanas después del nacimiento. Consiste en una obstrucción nasal bilateral con rinorrea seropurulenta y hemorrágica. La formación de costras que obstruyen los orificios nasales completa la tríada sintomática.

Una erosión con fisuras narinales llama la atención del rinólogo y hace investigar otros estigmas de esta fetopatía. Más tarde, la tríada de Hutchinson que asocia queratitis intersticial, sordera de percepción y malformaciones dentales completa el cuadro clínico de sífilis congénita *(figs. 3 y 4).*

OTRAS TREPONEMATOSIS

Algunas treponematosis no venéreas son endémicas en las regiones rurales de África central, del sur de Asia y de América. La transmisión suele ser directa.

3 *Sífilis congénita; estrechamiento de los orificios nasales (fotografía cortesía del Dr Souissi).*

4 *Sífilis congénita (fotografía cortesía del Dr. Kamoun).*

Pian

Está causado por el *Treponema pertenue*: se da en las regiones forestales húmedas. Los niños presentan lesiones cutáneas muy contagiosas, que evolucionan, como en la sífilis, hacia lesiones mutilantes, sobre todo a nivel de la nariz y la laringe. No hay ninguna reacción serológica que permita distinguir el pian de la sífilis.

Bejel

Está producido por un treponema de tipo pallidum (variedad endémica): se da en regiones secas y áridas, semidesérticas, sobre todo en los nómadas. Es una enfermedad infantil, poco mutilante.

Pinta o carate

El agente patógeno es el *Treponema carateum*, morfológica e inmunológicamente idéntico a los otros treponemas. Aparecen lesiones diseminadas sobre todo el cuerpo, produciendo una leucomelanodermia benigna.

Complicaciones

LOCALIZACIONES EN LOS SENOS DE LA CARA

La lesión sinusal es más una complicación de una sífilis nasal que una verdadera entidad clínica (Guerrier [4]). Hay más lesiones óseas que mucosas. Kuttner admitía que en los sifilíticos no tratados las lesiones sinusales aparecían en aproximadamente el 15 % de los casos, en la fase terciaria. Todos los senos de la cara pueden afectarse, aunque con mayor frecuencia los frontales y los etmoidales. Las paredes de los senos están afectadas por una ulceración gomosa o por la extensión de un proceso osteítico adyacente. Los secuestros de las partes necrosadas no tienen ningún límite, pudiendo producirse accidentes graves, incluso mortales.

PERFORACIÓN DEL TABIQUE NASAL

Puede limitarse al tabique cartilaginoso o ser más extensa. Se suele asociar a una perforación del paladar óseo.

DEFORMACIÓN DE LA PIRÁMIDE NASAL

Por destrucción de la estructura osteocartilaginosa que da una nariz deformada de loro, en anteojo, en silla de montar, en pata de marmita.

SINEQUIAS

Por unión de dos superficies denudadas, lo que provoca un estrechamiento de la vía nasal.

RINITIS ATRÓFICA COSTROSA

Por destrucción de crestas y cornetes.

COMPLICACIONES CEREBRALES

Por osteítis de los huesos de la cara y denudación de la duramadre, meningitis agudas, tromboflebitis de los senos cavernosos y parálisis de los nervios craneales.

Diagnóstico

DIAGNÓSTICO POSITIVO

Se basa en la clínica, la bacteriología, la serología, raramente en la histopatología.

Clínica

El chancro de inoculación, las sifílides y los gomas caracterizan, respectivamente, los tres estadios de la sífilis nasal.

Diagnóstico bacteriológico

Hay que recoger serosidad con una ansa, un vaccinostilo o una pipeta de Pasteur a nivel de las lesiones erosionadas o ulceradas, correctamente limpiadas. Este estudio, con el microscopio de campo oscuro, puede permitir plantear el diagnóstico. También se puede realizar un estudio por inmunofluorescencia sobre una preparación de serosidad extendida y fijada sobre una lámina. No obstante, un resultado negativo no excluye el diagnóstico.

Diagnóstico serológico

La serología no será detallada aquí. Se distinguen dos tipos de reacción.

Reacciones no específicas

Utilizan un antígeno cardiolipídico:
— Kline VDRL *(veneral disease research laboratory)*: es la reacción más utilizada.
— RPR *(Rapid plasma reagin test).*
Estas reacciones son cuantitativas, permiten realizar el diagnóstico y controlar la evolución.

Reacciones específicas

Utilizan un antígeno treponémico.
— Test de inmovilización de los treponemas de Nelson.
— TPHA *(Treponema pallidum hemagglutinación assay)* es la reacción de referencia.
— FTA-Abs.
— Test ELISA.
Como lo preconizan los *Centers for disease control*, ante toda sífilis es conveniente solicitar sistemáticamente una serología HIV, ya que traduce una sexualidad de riesgo.

■ *Histopatología*

El granuloma sifilítico es poco específico. Existe una infiltración perivascular por linfocitos y plasmocitos, asociada a folículos de células grandes.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Se descartan otras granulomatosis de la nariz.

Tratamiento

TRATAMIENTO MÉDICO

La penicilina G es la terapéutica de elección. Se prescribe en su forma retardada, en dosis de 1 200 000 unidades por día, durante 30 días en caso de infección antigua y sólo 15 días en caso de sífilis secundaria. En caso de alergia a la penicilina, debe recurrirse a los macrólidos o a las ciclinas.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Es posible después de la estabilización de la enfermedad por el tratamiento médico. Para corregir las deformaciones de la pirámide nasal puede proponerse una rinoplastia funcional con injerto óseo. Para reparar las graves mutilaciones de la pirámide nasal y de la cara pueden realizarse diferentes tipos de colgajos locorregionales.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Ennouri A, Hajri H et Bouzouaa N. Syphilis nasale et paranasale. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-378-A-10, 1991, 4 p.

Bibliografía

[1] **ANDERSON J., MINDEL A., WILLIAMS P. – Primary and secondary syphilis 20 years experience.** – *Genitourin. Med.,* **1989,** *65,* **239-243.**

[2] **FOURNIER A. – Leçons sur la syphilis tertiaire.** – *Bureau du Journal de l'Ecole de Médecine,* **1875.**

[3] **GENIAUX M. – Syphilis primaire et secondaire. Epidémiologie, diagnostic, traitement.** – *Rev. Prat. (Paris),* **1991,** *41,* **663-670.**

[4] **GUERRIER Y., PRIVAT M. – La syphilis des sinus.** – *J. Fr. ORL,* **1962,** *11,* **223-242.**

[5] **MARTINEZ S.A., MOUNEY D.F. – Treponemal infections of the head and neck.** – *Otolaryngol. Clin. North Am.,* **1982,** *15,* **613-620.**

[6] **JACOD P., PITRE M. – Le chancre syphilitique de la muqueuse pituitaire.** – *Ann. Mal. Oreille,* **1923,** *42,* **119-150.**

[7] **PENÉ P., ANDRÉ L.J., ROUGEMONT A., BOURGEADE A., BARABÉ P. – La santé et la médecine en Afrique tropicale. In : Nouvelles perspectives en pratique quotidienne, T2.** – *Doin,* **éd., Paris, 1980.**

[8] **TOPPOZADA M., El GHAZZAOUI. – The human respiratory nasal mucosa in nasal syphilis.** – *Acta Otolaryngol. (Stockh.),* **1984,** *97,* **419-425.**

[9] **TOPPOZADA H., TALAAT M., El WANY S. – The human respiratory nasal mucosa in nasal syphilis. An ultra microscopic study.** – *Acta Otolaryngol. (Stockh.);* **1985,** *99,* **272-279.**